

个人资料请勿传阅，让我们共同来关注您的健康！

浙江大学医学院附属第二医院

体检报告表



体检卡号:	6125094855
报告日期:	2025年7月31日
单位名称:	网络医学中心（解放路、滨江、博奥）门诊2025(336706)
工作部门:	
姓名:	张喆
性别:	男
年龄:	49岁
病案号:	51770971

欢迎您关注“浙二国际保健中心”官方微信，可以用手机扫上图二维码
也可以直接搜索微信号“z2bjzx”

姓名：张喆 性别：男 年龄：49岁 体检号：6125094855
单位：网络医学中心（解放路、滨江、博奥）门诊2025 病案号：51770971

您本次检查、化验有以下异常：

1、一般检查

体重指数：29.9kg/m²
腰围：98cm

2、内科

内科现病史：高血压病 治疗中；高脂血症 治疗中

3、外科

外科手术史：胆囊切除术后

4、眼科

眼科现病史：双眼屈光不正
眼科手术史：右眼视网膜激光术后
眼底检查：双眼豹纹状近视眼底 视网膜动脉细 中轴反光增强
裂隙灯检查：双眼晶体密度增高

5、彩超室

甲状腺双侧叶实质回声不均伴多发结节 TI-RADS 3类
双侧颈动脉内中膜增厚
脂肪肝
胆囊切除术后，肝内外胆管不扩张
左肾结石
前列腺钙化灶

6、动脉硬化

双侧ABI值属正常范围，双下肢血管未见异常。右侧PWV值较预测值轻度偏高，提示血管弹性轻度下降。左侧PWV值在正常范围内，提示血管弹性良好。

7、放射科(CR)

颈椎退行性改变。

8、放射科(CT)

左肺下叶少许小钙化灶。

● 检验科

糖化血红蛋白A1c：5.8 %	□参考范围：4.0-6.0
糖化血红蛋白F：2.4 %	↑参考范围：0.1-1.3
葡萄糖：4.86 mmol/L	□参考范围：3.89-6.11
肌酐：102.9 μmol/L	↑参考范围：57.0-98.0
肾小球滤过率：73.23 mL/min	↓参考范围：>90.00
尿酸：488 μmol/L	↑参考范围：208-428
胱抑素C：1.18 mg/L	↑参考范围：<1.03
甘油三酯：2.02 mmol/L	↑参考范围：<1.70
高密度脂蛋白胆固醇：1.20 mmol/L	□参考范围：0.90-2.19
低密度脂蛋白胆固醇：1.90 mmol/L	□参考范围：<3.36
肌酸激酶：183 U/L	↑参考范围：<164

体检小结及建议：

1、*血肌酐增高 肾小球滤过率降低 胱抑素C增高

【医学解释】：肌酐是临床肾功能检验的重要指标之一。肌酐是肌酸的代谢产物，由肾脏排泄。血肌酐升高见于各种原因引起的肾小球滤过功能减退，但仅一次轻度升高不一定有意义。

肾小球滤过率是早期了解肾脏功能减退的有效指标，指导肾脏疾病的诊断和治疗。

胱抑素C可以更敏感地反映肾功能的异常，但炎症、肿瘤及免疫疾病也可导致它增高。

【建议】：健康管理门诊/肾内科门诊就诊复查。

2、高血压病 高脂血症（治疗中） 双侧颈动脉内中膜增厚 血管弹性下降 视网膜动脉细 中轴反光增

强

【医学解释】：高血压与遗传因素、长期精神紧张、肥胖、水盐代谢等因素有关。大多数起病缓慢，缺乏特殊的临床表现，常见症状有头晕、头痛、颈项板紧、疲劳、心悸等。高血压病常见并发症有高血压性心脏病、脑血管病、慢性肾功能衰竭、心力衰竭等。

血脂异常通常指血清中胆固醇和（或）甘油三酯水平升高，俗称高脂血症。实际上血脂异常也泛指包括低高密度脂蛋白胆固醇血症在内的各种血脂异常。血脂异常的主要危害是增加动脉粥样硬化性心血管疾病的发病危险。

颈动脉内中膜增厚往往是动脉粥样硬化的早期表现，动脉粥样硬化多见于40岁以上的男性和绝经后的女性。本病的危险因素包括：高龄、高血压、血脂异常、糖尿病、吸烟、嗜酒、肥胖、遗传因素、体力活动减少、性情急躁等。颈动脉粥样硬化往往提示全身血管动脉粥样硬化，包括冠状动脉及脑动脉。

血管弹性下降多由脂质代谢异常引起动脉粥样硬化，以及长期血管压力过大导致动脉内膜病变所致。另外，随着年龄老化，血管弹性亦逐渐下降。

视网膜动脉硬化/视网膜动脉细/中轴反光增强：多见于高血压眼底改变，亦存在于老年人。

【建议】：低盐低脂饮食，忌烟限酒，适当多食蔬菜水果，适当体育锻炼，控制体重，监测血压、血糖及血脂等，避免情绪激动，按时服用降压药，定期自测血压并做好记录，健康管理门诊/全科门诊随诊，继续当前治疗方案，6-12个月复查血脂，半年复查颈动脉B超，每年复查眼底。

3、高尿酸血症

【医学解释】：1) 日常饮食下，非同日两次空腹血尿酸水平 $>420\mu\text{mol/L}$ 即可诊断高尿酸血症（HUA）。2) HUA是嘌呤代谢障碍引起的代谢性疾病。常与肥胖、糖脂代谢紊乱、高血压、动脉硬化和冠心病等聚集发生。少数患者可以发展为痛风，出现急性关节炎、痛风肾和痛风石等临床表现。3) 血液系统肿瘤、慢性肾功能不全、先天性代谢异常、中毒、药物等因素可引起血尿酸水平升高。

【建议】：忌烟限酒，少吃动物内脏、动物浓汤、海鲜及大肠、香肠等高嘌呤饮食，减少含糖饮料的摄入，增加新鲜蔬菜及含糖较少的水果的摄入，多饮水（心肾功能正常者，每日2000ml以上），控制体重。风湿免疫科/内分泌科门诊就诊，降尿酸治疗。

4、左肺下叶少许小钙化灶

【医学解释】：肺部钙化灶多属于陈旧性病灶，通常是结核、炎症或其他肺部损伤修复留下的钙化样瘢痕，影像表现为边缘清楚的高密度影，一般不需治疗。

【建议】：忌烟，健康管理门诊随诊，每年复查。

5、脂肪肝

【医学解释】：脂肪肝为常见肝病之一，包括酒精性和非酒精性脂肪肝。好发于肥胖、过量饮酒、高脂饮食、糖尿病等人群。少数病情可进展为肝硬化等。

【建议】：低脂低糖饮食，忌酒，适当运动，减轻体重，健康管理门诊随诊，6个月复查。

6、肥胖

【医学解释】：肥胖是遗传、环境等多种因素相互作用的结果，也是心脑血管疾病、呼吸系统疾病、糖尿病和肿瘤等多种疾病的重要危险因素。减重可以预防和治疗肥胖相关性并发症改善健康状况。BMI的计算公式是体重（kg）除以身高（m）的平方。中国成人BMI正常范围18.5-23.9， ≥ 24 为超重， ≥ 28 为肥胖。成人腰围 ≥ 90 厘米（男性）或 ≥ 85 厘米（女性）为中心性肥胖。

【建议】：健康的减肥方式是在均衡饮食、减少热能摄入的基础上增加合适的运动量。健康管理门诊/营养科门诊就诊。

7、代谢综合征

【医学解释】：代谢综合征是一种以腹型肥胖、高血糖、高血压以及血脂异常为特征的代谢紊乱性疾病。只要满足以下5项中任何3项及以上就能诊断：1. 腰围 $\geq 90\text{cm}$ （亚洲男性），腰围 $\geq 80\text{cm}$ （亚洲女性）；2. 血压 $\geq 130/85\text{mmHg}$ 和（或）已确诊为高血压并治疗者；3. 空腹血糖 $\geq 5.6\text{mmol/L}$ ，或已诊断为2型糖尿病并治疗。4. 甘油三酯 $\geq 1.7\text{mmol/L}$ 或已接受治疗；5. 高密度脂蛋白胆固醇： $<1.03\text{mmol/L}$ （男）， $<1.29\text{mmol/L}$ （女），或已接受治疗。

【建议】：低脂低盐低糖饮食，忌烟限酒，适当体育锻炼，监测血压、血糖、血脂，健康管理门诊就诊。

8、肾结石

【医学解释】：肾结石是尿石症的一种，多数位于肾盂肾盏内，肾实质结石少见，可引起肾绞痛、血尿。

【建议】：适当多饮水、适当运动，3个月复查B超，健康管理门诊/泌尿外科门诊随诊。

9、甲状腺双侧叶实质回声不均伴多发结节 TI-RADS 3类

【医学解释】：甲状腺实质回声不均匀是超声所见的一类表现，常见于自身免疫性甲状腺炎，如桥本甲状腺炎等，可伴或不伴甲状腺功能异常。

甲状腺内的肿块统称甲状腺结节，是常见的甲状腺疾病。分良性及恶性，良性结节占大多数。一般无症状，多为体检发现。目前以TI-RADS分类来评估良恶性的可能性，1-3类基本是良性病变，可以观察；4-5类有恶性可能，需要穿刺活检或手术来明确性质。

【建议】：健康管理门诊随诊，每半年复查甲状腺B超及T3T4全套。

10、糖尿病前期?

【医学解释】：6.1mmol/L≤空腹血糖<7.0mmol/L，或7.8mmol/L≤餐后2小时血糖<11.1mmol/L，或5.7%≤糖化血红蛋白A1c<6.5%，为“糖尿病前期”。“糖尿病前期”通过生活方式干预能够明显减少、延缓糖尿病的发生。

【建议】：（1）健康管理门诊/全科门诊就诊，进一步行葡萄糖耐量试验（OGTT）检查。（2）忌烟限酒，调整饮食总能量、饮食结构，适量运动，控制体重，坚持自我监测血糖，每3个月复查糖化血红蛋白。

11、颈椎退行性改变

【医学解释】：颈椎退行性改变由于椎间隙狭窄，关节囊、韧带松弛，造成颈段脊柱不稳定的恶性循环，最后出现脊髓、血管或神经刺激或压迫的表现。

【建议】：注意颈部姿势，适当颈部活动，枕头不宜过高，避免长期伏案工作和低头看手机，必要时骨科专科诊治。

12、双眼豹纹状近视眼底 晶体密度增高

【医学解释】：近视度数6.00D以上为高度近视，6.00D-3.00D为中度近视，3.00D以下为轻度近视。豹纹状眼底、漆裂样纹、斑块状视网膜脉络膜萎缩可以在高度近视和老年人的眼底，是一种视网膜脉络膜萎缩的表现。

【建议】：养成良好的用眼卫生习惯。如出现眼前黑影、闪光感或视力下降时，请及时眼科门诊就诊；如无不适应，眼科门诊随诊，每6-12个月复查眼底、验光等。

13、肌酸激酶增高

【医学解释】：肌酸激酶增高分生理性和病理性，近期剧烈运动、肌肉拉伤、过度劳累等因素导致的生理性增高最为常见；病理性增高常见于以下情况：心肌损伤，如心肌梗死、急性心肌炎、心包炎等；进行性肌萎缩、肌炎、皮肌炎等；颅脑外伤后、癫痫发作、惊厥、脑膜炎及脑炎等；甲状腺功能异常、药物、酒精中毒等。偶尔一次轻度增高不一定有临床意义。

【建议】：健康管理门诊随诊，暂停剧烈运动后1个月内复查。

14、前列腺钙化灶

【医学解释】：前列腺钙化灶是前列腺内的局部钙盐沉着。一般无症状，通常不需治疗。

【建议】：如无症状，不必治疗，每年复查B超，健康管理门诊随诊；如有尿频尿急尿痛或排尿不畅等不适，泌尿外科门诊就诊。

总检医生：颜杨杨/徐媛英

审核医生：贺肖洁

总检日期：2025-07-23

审核日期：2025-07-31

体检医院：浙江大学医学院附属第二医院

温馨提示：

1. 体检结论仅根据本次所检项目结果所做，可能难以全面反映您的健康状况。
2. 您过去患的疾病，因这次体检范围所限未能发现到的情况，仍按原诊断及治疗。
3. 查出的疾病请及时到专科就诊治疗。
4. 若需复查相关异常体检指标，或有不明之处可来健康管理中心健康咨询门诊，我们将提供优质的健康保健指导。
5. 为了尊重和保护您的个人隐私，本保健中心在每一份体检报告上都粘有封口袋，请您取到体检报告后确认封口带的完整性。
6. 放射科胶片实行自主打印，如您需要请体检当日起两个月内凭取件回单在放射科自助取片机上取片。

体检明细指标

一般检查

项目名称	检查结果	单位	参考范围
身高	176	cm	
体重	92.7	kg	
体重指数	29.9	kg/m ²	18.5~23.9

T值0.15Z值1.05

骨质正常

体检日期：2025/7/18 7:56:27检查者:刘琰

以下检验结果

GB212糖化血红蛋白全套

项目名称	检查结果	参考值	单位	项目名称	检查结果	参考值	单位
糖化血红蛋白A1	7.3	6.1-8.2	%	糖化血红蛋白A1c	5.8	4.0-6.0	%
糖化血红蛋白F	2.4	0.1-1.3	%	估计血浆平均葡萄糖浓度	6.6	4.2-7.8	mmol/L

检验日期：2025年7月18日 7:50:23报告日期：2025年7月18日检验者：1656_陈小华 审核者：陈慧莉

本报告仅对所检测样本负责

JYK213-尿液肾功能系列

项目名称	检查结果	参考值	单位	项目名称	检查结果	参考值	单位
尿微量白蛋白	<25.00	<25.00	mg/g.Cr	尿免疫球蛋白G	1.90	<12.00	mg/g.Cr
尿转铁蛋白	<2.90	<2.90	mg/g.Cr	尿α1微球蛋白	5.97	<15.00	mg/g.Cr
尿NAG酶	3.05	<20.00	U/g.Cr	尿Cr	2.26		g/L

检验日期：2025年7月18日 8:58:12报告日期：2025年7月18日检验者：2378_张松照 审核者：肖于飞

本报告仅对所检测样本负责

JYK217-T3、T4全套（甲状腺激素）

项目名称	检查结果	参考值	单位	项目名称	检查结果	参考值	单位
总三碘甲状腺原氨酸TT3	1.76	0.98-2.33	nmol/L	游离三碘甲状腺原氨酸FT3	4.53	2.43-6.01	pmol/L
总甲状腺素TT4	91.6	62.7-150.8	nmol/L	游离甲状腺素FT4	12.02	9.01-19.05	pmol/L
高敏促甲状腺素TSH	2.90	0.35-4.94	mIU/L	甲状腺球蛋白TG	10.00	3.50-77.00	μg/L
甲状腺球蛋白抗体ATGAb	0.81	<4.11	IU/mL	过氧化物酶抗体TPOAb	1.28	<5.61	IU/mL

检验日期：2025年7月18日 7:50:23报告日期：2025年7月18日检验者：2378_张松照 审核者：黄希颖

本报告仅对所检测样本负责

JYK261-（空腹）胰岛素测定

项目名称	检查结果	参考值	单位	项目名称	检查结果	参考值	单位
胰岛素(空腹)	172.5	20.9-174.1	pmol/L				

检验日期：2025年7月18日 7:50:23报告日期：2025年7月18日检验者：2378_张松照 审核者：黄希颖

本报告仅对所检测样本负责

鼻咽癌三项

项目名称	检查结果	参考值	单位	项目名称	检查结果	参考值	单位
Rta/IgG抗体	阴性	<1.00(-)	S/CO	EA/IgA抗体	阴性	<1.10(-)	S/CO

EBV衣壳抗原 IgA 阴性 <1.10(-) S/CO

检验日期：2025年7月18日 7:50:23 报告日期：2025年7月21日 检验者：2378_张松照 审核者：肖于飞

本报告仅对所检测样本负责

粪常规(找原虫, 隐血)							
项目名称	检查结果	参考值	单位	项目名称	检查结果	参考值	单位
大便颜色	黄色	黄色		大便性状	软便	软	
大便红细胞	阴性	阴性	/HP	大便白细胞	阴性	阴性	/HP
大便隐血	阴性	阴性		寄生虫	未检测到	无	

检验日期：2025年7月18日 10:27:55 报告日期：2025年7月18日 检验者：JL084_包林梅 审核者：俞爱群

本报告仅对所检测样本负责

各类呼气试验							
项目名称	检查结果	参考值	单位	项目名称	检查结果	参考值	单位
HP尿素呼气试验	0.82	<4.00	DOB				

检验日期：2025年7月18日 13:03:59 报告日期：2025年7月18日 检验者：JG221_徐国萍 审核者：朱永良

本报告仅对所检测样本负责

尿常规+有形成分测定							
项目名称	检查结果	参考值	单位	项目名称	检查结果	参考值	单位
尿液颜色	黄色	淡黄色		浊度	清	清	
尿亚硝酸盐	阴性	阴性		尿葡萄糖	阴性	阴性	mmol/L
尿蛋白	阴性	阴性	g/L	尿比重	1.020	1.003-1.030	
尿胆红素	阴性	阴性	μmol/L	尿酮体	阴性	阴性	mmol/L
尿pH	5.5	5.0-8.0		尿胆原	弱阳性	弱阳性	μmol/L
尿潜血	阴性	阴性	Ery/μL	尿白细胞酯酶	阴性	阴性	LEU/μL
尿白细胞	1	≤10	/μL	尿红细胞	2	≤8	/μL
尿鳞状上皮细胞	<1	≤2	/μL	尿非鳞状上皮细胞	<1	≤4	/μL
尿粘液丝	8	≤137	/μL	尿草酸钙结晶	<1	≤14	/μL
尿酸结晶	<1	≤14	/μL	管型	<1	≤1	/μL

检验日期：2025年7月18日 8:58:12 报告日期：2025年7月18日 检验者：1897_张正良 审核者：周俊

本报告仅对所检测样本负责

体检生化							
项目名称	检查结果	参考值	单位	项目名称	检查结果	参考值	单位
总蛋白	68.8	66.0-83.0	g/L	白蛋白	43.1	35.0-52.0	g/L
球蛋白	25.7	15.0-30.0	g/L	白蛋白/球蛋白比值	1.68	1.20-2.40	
总胆红素	15.2	<26.0	μmol/L	直接胆红素	2.7	<4.0	μmol/L
间接胆红素	12.5	5.0-20.0	μmol/L	总胆汁酸	4.5	<15.0	μmol/L
丙氨酸氨基转移酶	28	9-50	U/L	天冬氨酸氨基转移酶	23	15-40	U/L

γ-谷氨酰转肽酶	33	10-60	U/L	碱性磷酸酶	83	30-120	U/L
a-L-岩藻糖苷酶	21.0	14.3-39.9	U/L	肌酸激酶	183	<164	U/L
乳酸脱氢酶	196	120-250	U/L	同型半胱氨酸	13.8	<20.0	μmol/L
超敏C-反应蛋白	2.3	<5.0	mg/L	葡萄糖	4.86	3.89-6.11	mmol/L
肌酐	102.9	57.0-98.0	μmol/L	肾小球滤过率	73.23	>90.00	mL/min
尿素	7.51	2.80-7.60	mmol/L	尿酸	488	208-428	μmol/L
胱抑素C	1.18	<1.03	mg/L	甘油三酯	2.02	<1.70	mmol/L
总胆固醇	4.00	3.00-5.70	mmol/L	高密度脂蛋白胆固醇	1.20	0.90-2.19	mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇	1.90	<3.36	mmol/L	载脂蛋白A1	1.28	1.05-1.75	g/L
载脂蛋白B	0.68	0.60-1.40	g/L	淀粉酶	83	35-135	U/L
钾	3.81	3.50-5.30	mmol/L	钠	138.7	137.0-147.0	mmol/L
氯	106.9	99.0-110.0	mmol/L	钙	2.29	2.11-2.52	mmol/L
镁	0.80	0.75-1.02	mmol/L	磷	1.08	0.85-1.51	mmol/L

检验日期：2025年7月18日 7:50:22 报告日期：2025年7月18日 检验者：1656_陈小华 审核者：陈慧莉

本报告仅对所检测样本负责

维生素6项（体检）

项目名称	检查结果	参考值	单位	项目名称	检查结果	参考值	单位
维生素A	710.69	325-780	ng/mL	25-羟基维生素D	37.87	成人(≥18岁): 缺乏:<12 不足:12-20 正常:20-80 过量:>80 中毒:>150	ng/mL
25-羟基维生素D2	4.28		ng/mL	25-羟基维生素D3	33.59		ng/mL
维生素K	0.85	0.2-2.2	ng/mL	维生素E	10.39	0-17岁:3.8-18.4 ≥18岁:5.5-17.0	μg/mL

检验日期：2025年7月18日 7:50:23 报告日期：2025年7月21日 检验者：5339_桑奕雯 审核者：潘小艳

本报告仅对所检测样本负责

血常规

项目名称	检查结果	参考值	单位	项目名称	检查结果	参考值	单位
血红蛋白	163	131-172	g/L	红细胞计数	5.23	4.09-5.74	10 ¹² /L
红细胞压积	0.487	0.380-0.508	L/L	平均红细胞体积	93.2	84.0-94.0	fL
平均红细胞血红蛋白量	31.1	27.0-34.0	pg	平均红细胞血红蛋白浓度	335	320-380	g/L
红细胞分布宽度	12.7	12.0-15.0	%	白细胞计数	6.5	4.0-10.0	10 ⁹ /L
中性粒细胞绝对值	3.41	2.00-7.00	10 ⁹ /L	淋巴细胞绝对值	2.42	0.80-4.00	10 ⁹ /L
单核细胞绝对值	0.45	0.20-1.20	10 ⁹ /L	嗜酸性粒细胞绝对值	0.19	<1.00	10 ⁹ /L
嗜碱性粒细胞绝对值	0.03	<0.10	10 ⁹ /L	中性粒细胞百分比	52.4	50.0-70.0	%
淋巴细胞百分比	37.3	20.0-40.0	%	单核细胞百分比	6.9	4.0-12.0	%

嗜酸性粒细胞百分比	3.0	<10.0	%	嗜碱性粒细胞百分比	0.4	<1.0	%
血小板计数	180	100-300	10^9/L	血小板压积	0.197	0.106-0.250	%
血小板平均体积	11.0	7.8-11.3	fL				

检验日期：2025年7月18日 7:50:23 报告日期：2025年7月18日 检验者：1167_陈红兵 审核者：钟毓红

本报告仅对所检测样本负责

肿瘤标记物							
项目名称	检查结果	参考值	单位	项目名称	检查结果	参考值	单位
CEA	1.9	< 5	ng/mL	AFP	3.4	< 20	ng/mL
CA199	5.0	< 37	U/mL	CA125	8.1	< 35	U/mL
CA242	1.6	< 20	U/mL	CA211	3.8	< 5	ng/ml
NSE	15.3	< 25	ng/ml	SCC	1.0	< 1.5	ng/ml
PSA	0.5193	< 4.0000	ng/mL	f-PSA	0.2620	< 1.0000	ng/ml
f/T PSA	0.50	> 0.18					

检验日期：2025年7月18日 7:50:22 报告日期：2025年7月18日 检验者：0153_蒋文智 审核者：方永明

本报告仅对所检测样本负责

彩超室

项目名称	检查结果	检查结论
肝胆胰脾彩超检查+ 双侧甲状腺彩超检查 +双侧颈动脉彩超检查 +双肾输尿管膀胱 前列腺彩超	甲状腺双侧叶大小、形态正常，包膜光整，实质回声不均匀，在甲状腺实质各见多个椭圆形低回声结节，右侧较大者约0.3cm，左侧较大者约0.5*0.2cm，边界及周边可辨，内部回声不均，CDFI示其内未见明显血流信号。彩色多普勒检查实质内血流未见异常。 双侧颈动脉内径正常，内中膜增厚，较厚处约0.11cm，内膜不光整，动脉腔内未见明显异常回声，动脉腔未见狭窄，动脉内彩色多普勒血流充填良好。 肝脏大小正常，包膜光整，肝实质光点细密，回声增高，分布均匀，肝实质内未见明显占位性病变，肝实质后方回声衰减，肝内血管走行显示欠清，门静脉内径正常范围，内部透声好，CDFI显示血流充盈佳。 胆囊切除术后，肝内胆管未见明显扩张，总胆管上段内径正常，总胆管内未见异常回声。 胰腺大小形态正常，胰腺实质内回声均匀，CDFI未见异常。脾脏大小正常，形态规则，包膜光整，脾实质内回声均匀,CDFI未见异常。 左侧肾脏大小正常，形态规则，包膜光整，实质回声均匀，皮髓质分界清晰，肾实质内未见明显占位性病变，集合系统未见明显分离，在肾集合系统内见一个强光团，大小约0.5cm，后方伴声影，CDFI示肾血流充盈良好。 前列腺大小正常，两侧叶对称，包膜光整，实质内回声不均匀，并可见高回声斑，未见明显占位性病变，彩色多普勒血流检查未见异常血流。 右侧肾脏大小正常，形态规则，包膜光整，实质回声均匀，皮髓质分界清晰，肾实质内未见明显占位性病变，集合系统未见明显分离，CDFI示肾血流充盈良好。双侧输尿管未见明显扩张。膀胱充盈后扫查，膀胱壁光整，膀胱内未见异常回声。	甲状腺双侧叶实质回声不均伴多发结节 TI-RADS 3类 双侧颈动脉内中膜增厚 脂肪肝 胆囊切除术后，肝内外胆管不扩张 胰腺、脾脏未见明显异常 左肾结石 前列腺钙化灶 右肾、双侧输尿管、膀胱未见明显异常

检查日期：2025年7月18日 检查医生:许俊

放射科 (CR)

项目名称	检查结果	检查结论
颈椎侧位	颈椎生理性曲度变直。颈椎前、后缘骨质增生。椎体附件未见明显异常。椎间隙未见明显狭窄。	颈椎退行性改变。
检查日期：2025年7月18日		检查医生:钱微

放射科 (CT)

项目名称	检查结果	检查结论
CT胸部平扫	肺部体检CT检查： 肺窗显示两肺支气管血管束清晰，走向分布无异常，左肺下叶少许小钙化结节，敬业3-4mm，余肺实质未见明显渗出或实质性占位性病变。 附见：胆囊术后改变。	左肺下叶少许小钙化灶，请随诊。
检查日期：2025年7月18日		检查医生:周佳萍

常规心电图

项目名称	检查结果	检查结论
心电图	窦性心律 正常范围心电图	窦性心律 正常范围心电图
检查日期：2025年7月18日		检查医生:沈军军



浙江大学医学院附属第二医院
颈、颅多普勒检查报告

姓名	张喆	TCD ID	6125094855
性别	男	检查日期	2025-07-18
年龄	49	体检卡编码	6125094855
科室	体检	病案号	51770971

TCD相关：
(下表中，Peak、Mean、Dias的单位为cm/s，Depth单位为mm，其余参数无单位)

血管名	Depth	Peak	Mean	Dias	PI	RI	SBI	S/D	HR
LCCA	-	75	35	15	1.71	0.80	0.33	5.00	91
LICA	-	-49	-30	-20	0.98	0.59	0.53	2.45	86
LECA	-	-36	-17	-7	1.74	0.81	0.55	-	86
RCCA	-	61	30	15	1.52	0.75	0.37	4.07	83
RICA	-	-51	-32	-23	0.87	0.55	0.55	2.22	77
RECA	-	-55	-25	-10	1.80	0.82	0.57	-	87
LMCA	55	95	58	40	0.94	0.58	0.52	2.38	77
RMCA	55	89	50	31	1.15	0.65	0.53	2.87	88
BA	90	-68	-41	-28	0.97	0.59	0.78	2.43	103
LVA	50	-34	-22	-16	0.82	0.53	0.04	2.13	101
RVA	50	-35	-21	-14	1.00	0.60	0.24	2.50	88

诊断结论：
双侧大脑中动脉血流速度对称、频谱形态正常；
双侧椎动脉-基底动脉血流速度及频谱形态正常；
双侧颈总动脉、颈内动脉颅外段、颈外动脉血流速度及频谱形态正常。
TCD提示：
TCD探及血管血流速度及频谱形态未见明显异常。

医生签名：张雪梅
报告日期：2025-07-18



浙江大学医学院附属第二医院超声诊断报告单

病案号: 51770971

超声号: US19666507

姓名: 张喆

性别: 男

年龄: 49岁

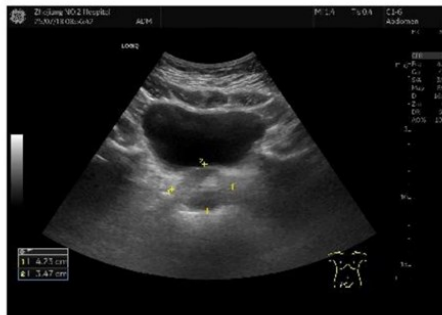
病区:

床号:

科室: 门诊体检-解放路

临床诊断:

检查项目: 双侧甲状腺彩超检查(双侧), 肝胆胰脾彩超检查, 双肾输尿管膀胱前列腺彩超, 双侧颈动脉彩超检查



检查所见:

甲状腺双侧叶大小、形态正常,包膜光整,实质回声不均匀,在甲状腺实质各见多个椭圆形低回声结节,右侧较大者约0.3cm,左侧较大者约0.5*0.2cm,边界及周边可辨,内部回声不均,CDFI示其内未见明显血流信号。彩色多普勒检查实质内血流未见异常。

双侧颈动脉内径正常,内中膜增厚,较厚处约0.11cm,内膜不光整,动脉腔内未见明显异常回声,动脉腔未见狭窄,动脉内彩色多普勒血流充填良好。

肝脏大小正常,包膜光整,肝实质光点细密,回声增高,分布均匀,肝实质内未见明显占位性病变,肝实质后方回声衰减,肝内血管走行显示欠清,门静脉内径正常范围,内部透声好,CDFI显示血流充盈佳。

胆囊切除术后,肝内胆管未见明显扩张,总胆管上段内径正常,总胆管内未见异常回声。

左侧肾脏大小正常,形态规则,包膜光整,实质回声均匀,皮髓质分界清晰,肾实质内未见明显占位性病变,集合系统未见明显分离,在肾集合系统内见一个强光团,大小约0.5cm,后方伴声影,CDFI示肾血流充盈良好。

胰腺大小形态正常,胰腺实质内回声均匀,CDFI未见异常。脾脏大小正常,形态规则,包膜光整,脾实质内回声均匀,CDFI未见异常。右侧肾脏大小正常,形态规则,包膜光整,实质回声均匀,皮髓质分界清晰,肾实质内未见明显占位性病变,集合系统未见明显分离,CDFI示肾血流充盈良好。

前列腺大小正常,两侧叶对称,包膜光整,实质内回声不均匀,并可见高回声斑,未见明显占位性病变,彩色多普勒血流检查未见异常血流。

提示:

甲状腺双侧叶实质回声不均伴多发结节 TI-RADS 3类

双侧颈动脉内中膜增厚

脂肪肝

报告时间:2025-07-18 08:52

会诊医师:

医师助理:彭军艳 检查医师:许俊 签名:

本报告仅供临床医师参考



浙江大学医学院附属第二医院超声诊断报告单

病案号: 51770971

超声号: US19666507

姓名: 张喆

性别: 男

年龄: 49岁

病区:

床号:

科室: 门诊体检-解放路

临床诊断:

检查项目: 双侧甲状腺彩超检查(双侧), 肝胆胰脾彩超检查, 双肾输尿管膀胱前列腺彩超, 双侧颈动脉彩超检查

胆囊切除术后, 肝内外胆管不扩张

左肾结石

胰腺、脾脏、右肾未见明显异常

前列腺钙化灶

报告时间: 2025-07-18 08:52 会诊医师:

医师助理: 彭军艳 检查医师: 许俊 签名:

本报告仅供临床医师参考



浙江大学医学院附属第二医院

SECOND AFFILIATED HOSPITAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE



微信扫码查看影像

普放检查诊断报告单（体检）

姓名 张喆 性别 男 年龄 49岁 病案号 51770971
科室 门诊体检-解放路 检查项目 颈椎侧位片

影像所见 Image Findings

颈椎生理性曲度变直。颈椎前、后缘骨质增生。椎体附件未见明显异常。椎间隙未见明显狭窄。

诊断结果 Diagnosis

颈椎退行性改变。

报告医生：钱微 钱微

审核医生：钱微

钱微
7007

检查时间：2025-07-18 08:35

报告时间：2025-07-18 15:33

*数字影像查阅：请用微信扫码右上方二维码

若未在诊间支付数字影像服务费，可用微信扫码支付后开通查阅服务

*此单仅供临床医师参考，不作证明用；



浙江大学医学院附属第二医院

SECOND AFFILIATED HOSPITAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE



微信扫码查看影像

CT 检查诊断报告单（体检）

姓名 张喆 性别 男 年龄 49岁 病案号 51770971
科室 门诊体检-解放路 检查项目 胸部CT平扫

影像所见 Image Findings

肺部体检CT检查：

肺窗显示两肺支气管血管束清晰，走向分布无异常，左肺下叶少许小钙化结节，敬业3-4mm，余肺实质未见明显渗出或实质性占位性病变。

附见：胆囊术后改变。

诊断结果 Diagnosis

左肺下叶少许小钙化灶，请随诊。

报告医生：周佳萍

审核医生：周佳萍

周佳萍
9858

检查时间：2025-07-18 07:41

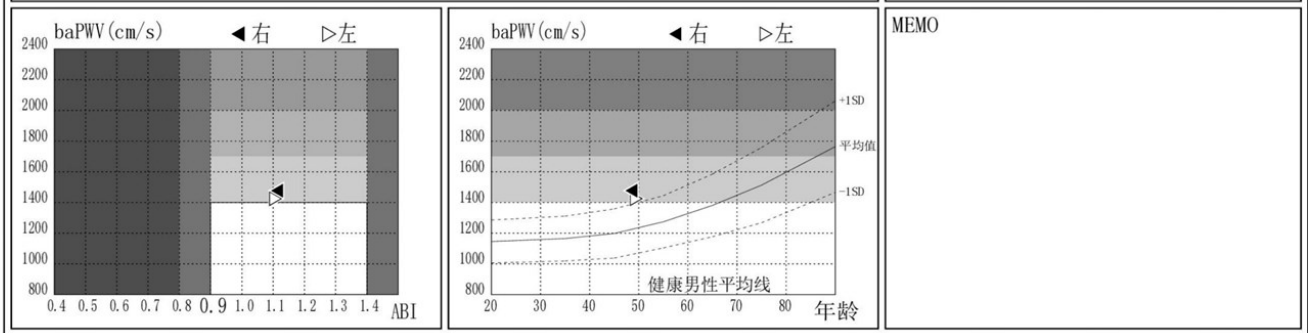
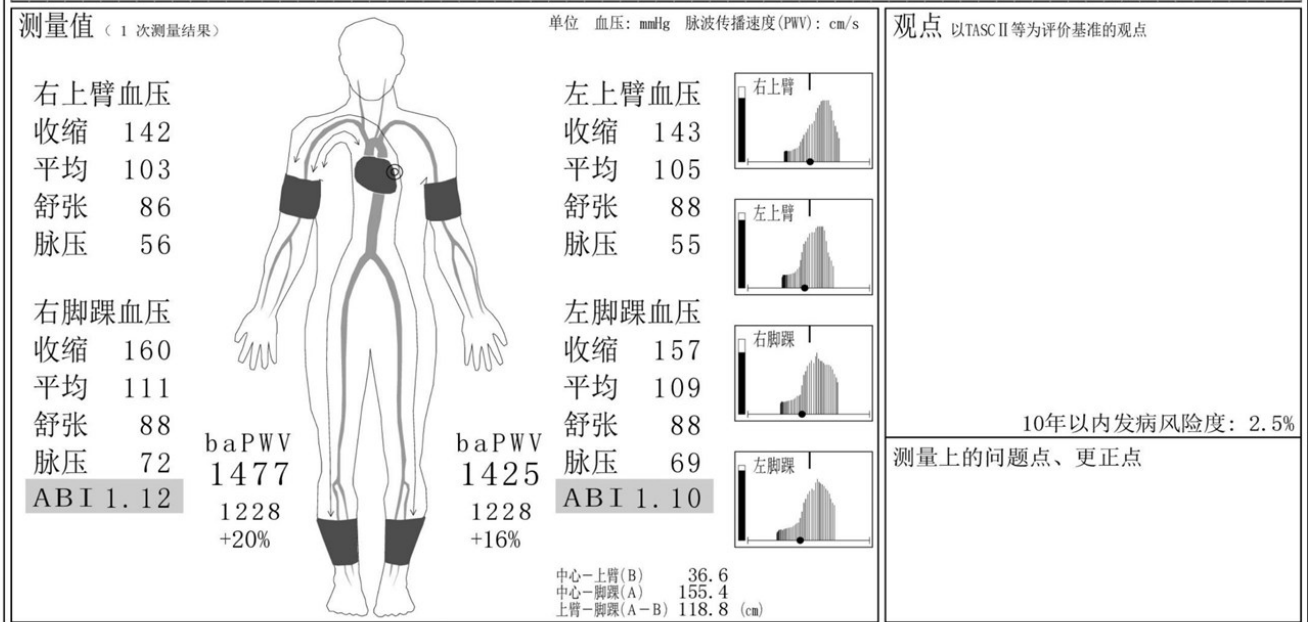
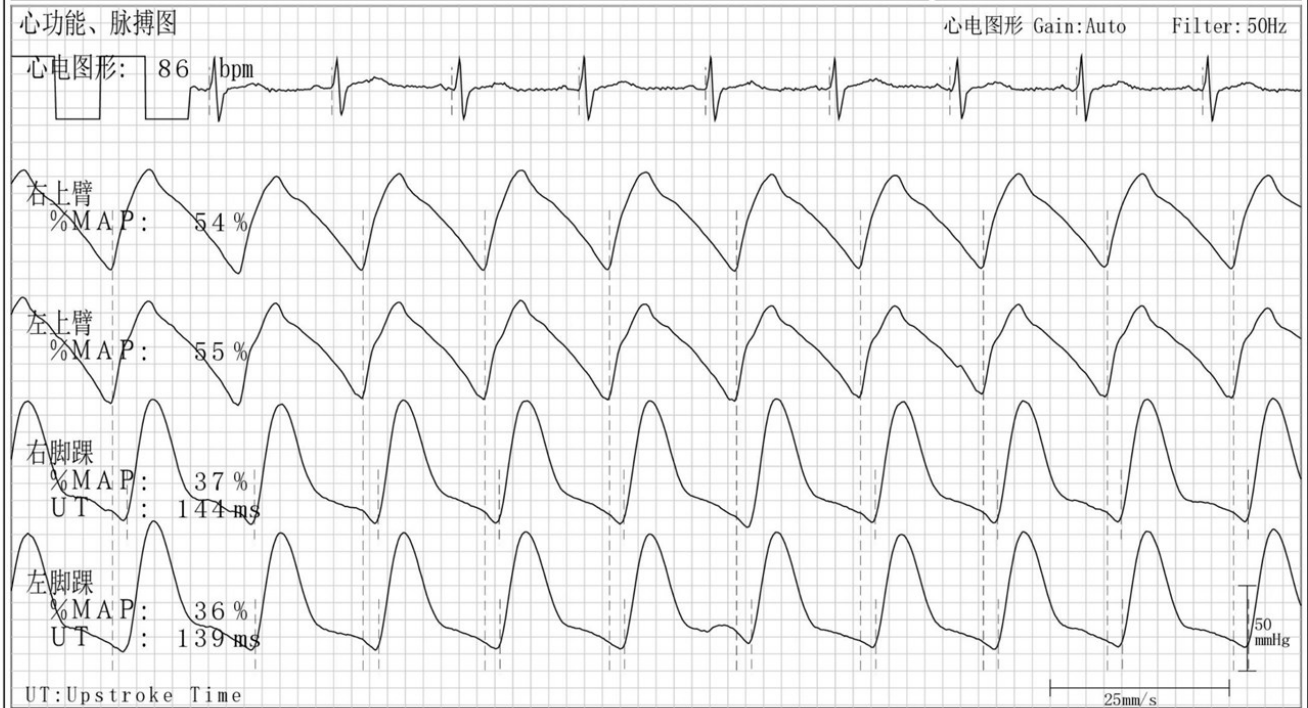
报告时间：2025-07-18 11:17

*数字影像查阅：请用微信扫描右上方二维码

若未在诊间支付数字影像服务费，可用微信扫码支付后开通查阅服务

*此单仅供临床医师参考，不作证明用；

ID: 6125094855		年龄: 49 岁	基础疾病:	医生:
姓名: 张喆		身高: 176 cm	体重: 92.7 kg	测量者: 赵娜
科室: 检查室		性别: 男性	腹围: --- cm	室温 (°C)
		BMI: 29.9		



B.M.Tech 超声骨密度检测结果报告

浙江大学医学院附属第二医院

受检者信息

受检者ID: 6125094855
姓名: 张喆
出生年月日: 1976-01-25

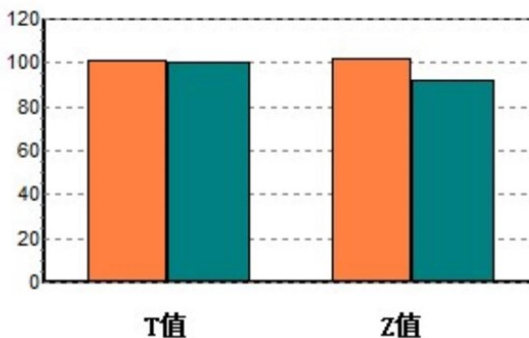
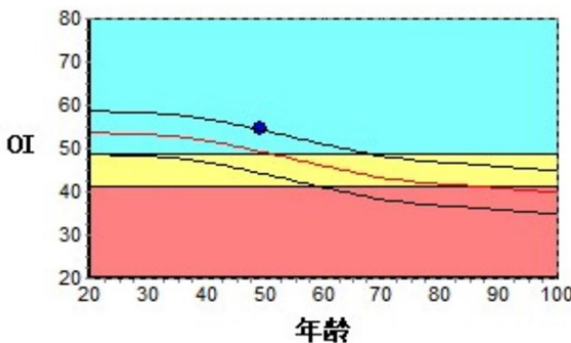
年龄: 49
性别: 男
测定部位(右/左): 右

测定结果

测定日期: 2025-07-18 7:55:11

测试编号: 1/1

受测者 平均值

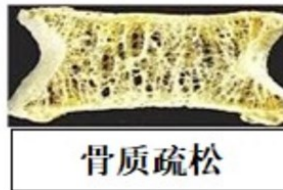
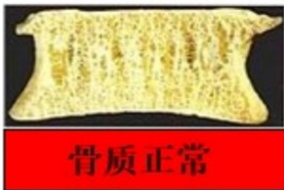


数据库: Asia
OI: 54.6
SOS: 1357.4 m/s
T值: 0.15
Z值: 1.05

, BUA: 47.5

成人比: 101.4 %
同龄比: 110.6 %
OPR: N/A %

结果分析



提示

骨质正常

该检查结果需结合临床, 数据来源于骨密度正常人参照值数据库

浙江大学医学院附属第二医院心电图报告单

姓名: 张喆

病案号: 51770971

性别: 男

床号:

年龄: 49岁

科室: 体检中心

心电图诊断:

窦性心律 正常范围心电图

心率: 70bpm

QRS: 110ms

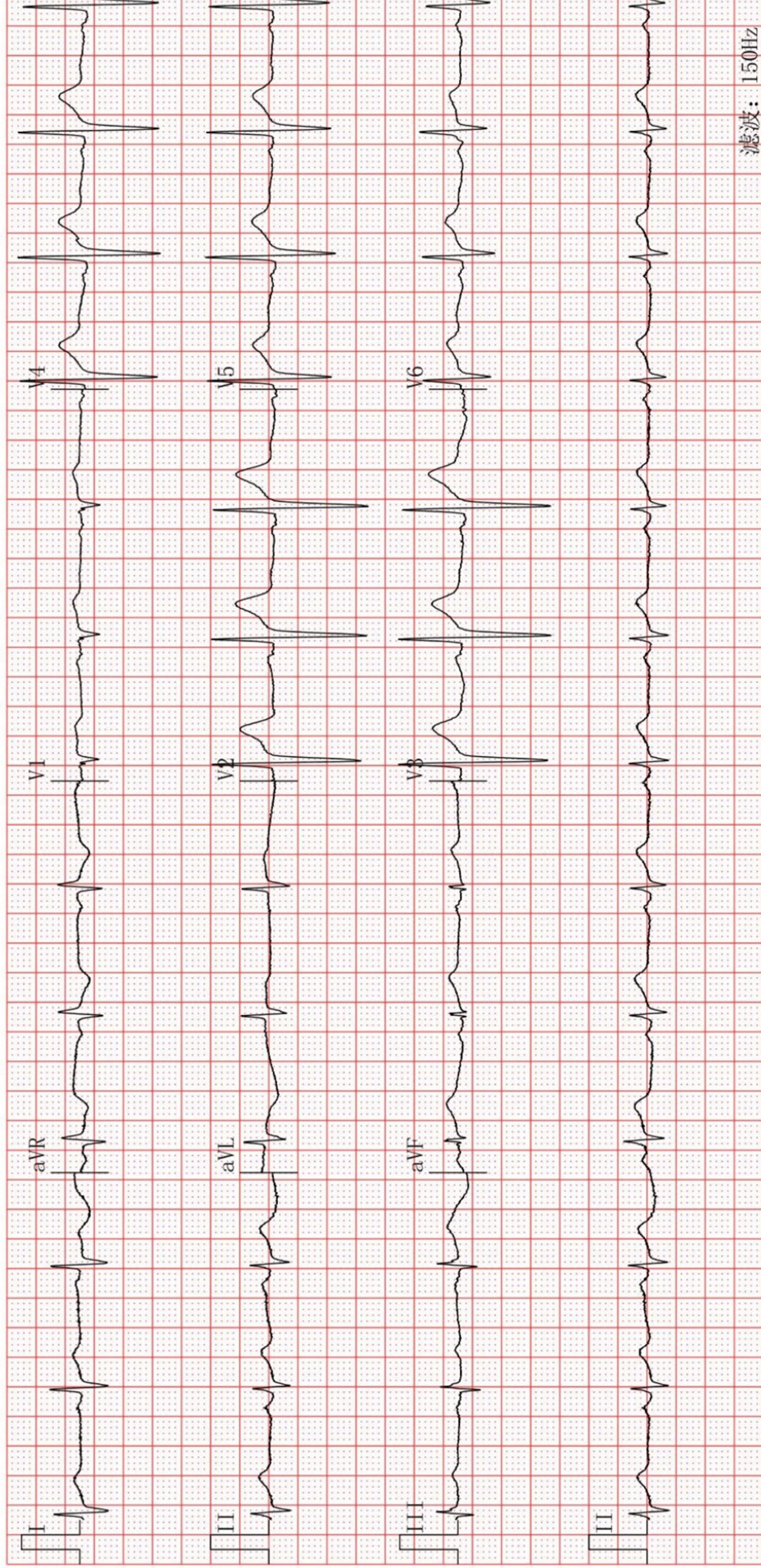
P-R间期: 148ms

QT/QTc: 368/397ms

QRS电轴: 76°

Rv5/Sv1: 1.18/0.28mV

本报告仅供参考, 请结合临床



采集时间: 2025-07-18 09:42:58

报告时间: 2025-07-18 09:57:27

审核医生:

灵敏度: 10mm/mV 纸速: 25mm/s

滤波: 150Hz

体检号: 6125094855

姓名: 张喆

性别: 男 年龄: 49岁

体检日期: 2025-07-18

第19页, 共19页